

Répertoire

Médecine de l'addiction

Jean-Bernard Daeppen
Jean-Bernard.Daeppen@chuv.ch

“La notion d’addiction envers une drogue ou une activité s’appuie sur un symptôme fondamental, *l’émergence d’un affect négatif* ressenti en son absence. Le degré de d’addiction peut se mesurer par la sévérité du malaise ressenti, allant *d’un léger inconfort à une détresse extrême*, ou bien par *l’ampleur de la difficulté ou de l’effort requis* pour vivre sans la drogue, l’objet, l’activité, ...”

Mécanismes insidieux d'induction de l'addiction

1. Tolérance, besoin de plus d'alcool ou de drogue pour ressentir des effets positifs
2. Renforcement positif : voir une bouteille de vin, ou une boulette de cocaïne d'abord de façon neutre, mais, progressivement, ressentir une forte envie
3. Diminution du niveau basal de dopamine et d'opioïde, comme si les fonctions de base du système de récompense ralentissaient
4. L'activation du système de stress induit inconfort and irritabilité
5. Stimulation du système de récompense et de la libération de dopamine pendant le craving
6. Altération du jugement réduisant la capacité de dire non au psychotrope auquel la personne est addictée

Combat inégal: pauvre cortex...

Une guerre civile à l'intérieur



Système limbique

Cortex préfrontal

**L'addiction ne concerne qu'une
minorité vulnérable de la population**



Evaluation multiaxiale

**Au moins 5 dimensions à
considérer!**

1. la crise
2. les ressources
3. la motivation
4. le somatique
5. la psychiatrie

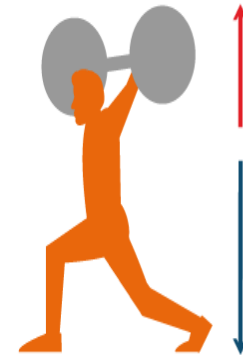
Traitement



Système limbique:
médication/traitement agoniste

Cortex préfrontal: relation
thérapeutique

Actuellement, l'efficacité des médicaments anti-craving est limitée...



C'est avant tout la relation qui soigne....

L'entretien motivationnel

Outils

Questions

ouvertes

Ecoute réflexive

Valorisations

Résumés

Planifier
comment changer?

Évoquer
pourquoi changer?

Focaliser
quel changement?

Créer un lien de confiance
entrer dans le monde du patient

Alcool

Signe d'insuffisance hépatocellulaire et d'hypertension



- Angiome stellaire (pathologique si >5)

- Ecchymoses spontanées ou provoquées par traumatismes mineurs, pétéchies (trouble de la synthèse des facteurs de la coagulation)



- Erythème palmaire

- Féminisation de l'homme : peau fine, perte de la pilosité, gynécomastie, diminution de la libido, atrophie testiculaire

- Hépatomégalie: >12 cm sur la ligne médio-claviculaire

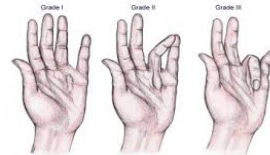
- Contour régulier : cirrhose, hépatite chronique
- Contour irrégulier : néoplasie
- palpation ferme : hépatite aiguë, surcharge non stéatosique
- palpation molle : stéatose

- Splénomégalie

- Circulation veineuse collatérale



- Maladie de Dupuytren



- Hypertrophie parotidienne

- Tension artérielle élevée



- Rythme irrégulier rapide → fibrillation auriculaire

- Nécrose de la tête fémorale

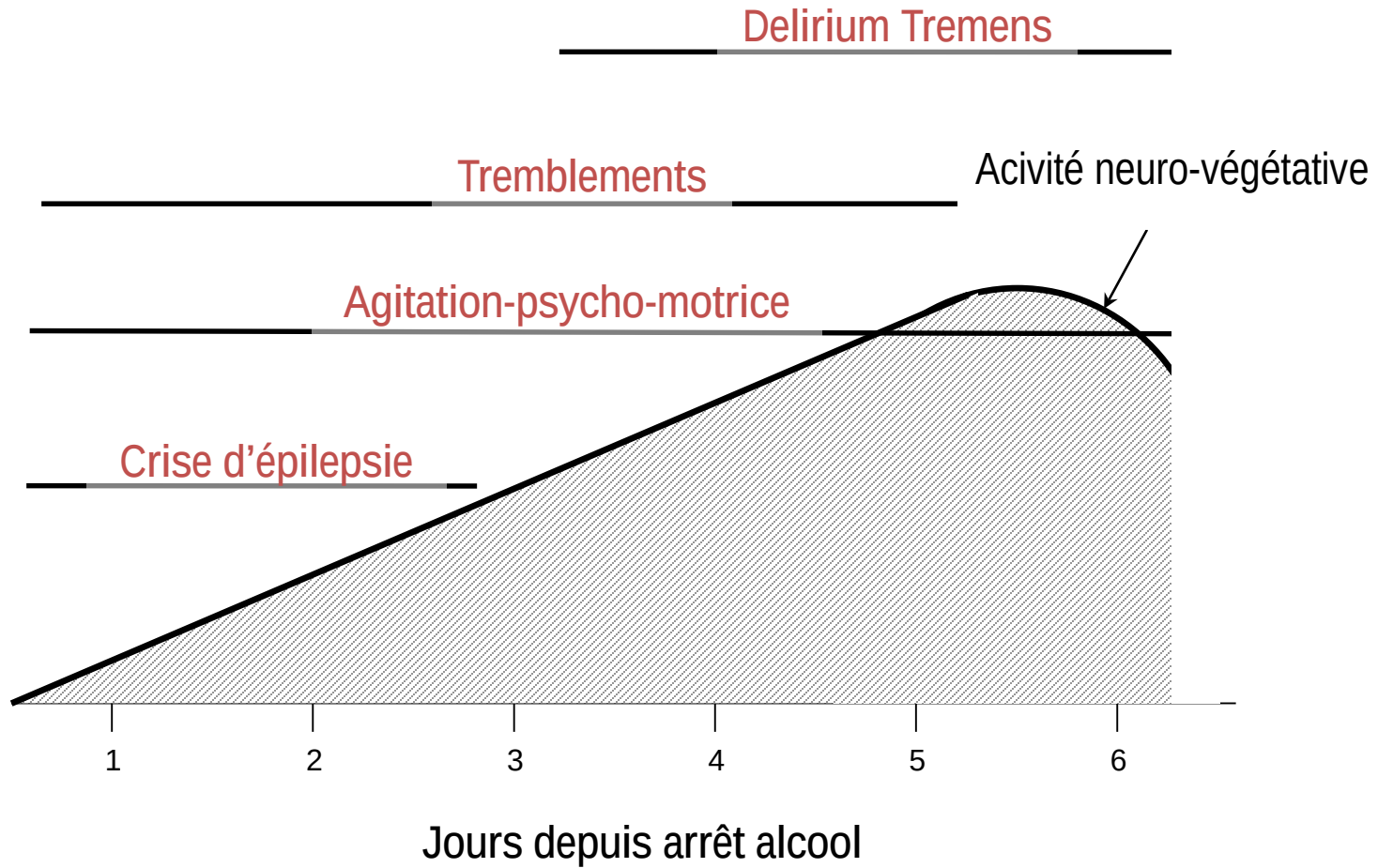
Gayet - Wernicke...

Le déficit aigu et sévère en thiamine se traduit par une encéphalopathie de Gayet-Wernicke, caractérisée par la survenue brutale d'un ou de plusieurs signes de la triade classique :

- Confusion
- Parésie des muscles oculomoteurs et/ou nystagmus
- Ataxie

Triade dans 10 % des cas seulement!

Sevrage



Repérer à temps

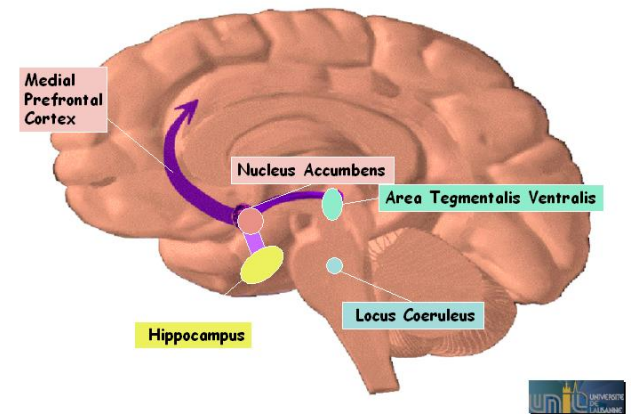
- Les signes initiaux du sevrage sont peu spécifiques, donc difficiles à repérer
- 10 % des patients hospitalisés sont alcooliques
- L'alcool n'est généralement pas la cause d'hospitalisation:
 - traumatisme, infection, cancers, maladies cardio-vasculaires
- Les symptômes de sevrage se manifestent souvent 24 – 48 heures après l'admission
- Le stress (opératoire notamment) « décompense » le sevrage alcoolique

Signes mineurs du sevrage d'alcool sont

- Agitation psycho-motrice
- Tremblements
- Insomnies
- Anxiété

Signes majeurs sont

- Epilepsie: crise tonico-clonique générali
- Delirium tremens: HTA, tachycardie, fièvre, agitation psycho-motrice majeure, hallucinations, mortalité 20 % sans traitement



Risque de sevrage compliqué

- Prise régulière de tranquillisants
- Co-morbidité médicale ou psychiatrique sévère
- Consommation maximale sur 24 h > 30 verres
- Signes de sevrage malgré alcoolémie > 1 g
- Antécédents de sevrage compliqué (épilepsie, deltrem)

Attention: la présence d'un de ces critères devrait inciter à un sevrage hospitalier

Traitement pharmacologique du sevrage

- Benzodiazépines
- Longue demi-vie
- Per os
- Ambulatoire
- Schéma fixe ou adapté
- Sevrage compliqué nécessitent soins continus pour administration IV

- La perfusion de solutions glucosées est contre-indiquée chez les patients alcoolo-dépendants parce que, la thiamine étant un cofacteur de l'absorption du glucose dans les neurones, l'administration intraveineuse de glucose va brutalement diminuer les taux de thiamine et déclencher ou accentuer une encéphalopathie de Gayet-Wernicke.

Cannabis



Effets du THC

Physiques

- Sécheresse bouche
- Yeux rouges
- Troubles locomotion
- Sensation de froid
- Myorelaxant
- Augmente l'appétit
- Antiémétique

Psychologiques

- Modif. état conscience, sons et lumière ++
- Euphorie, détente, calme intérieur
- Temps allongé
- Trouble attention, mémoire, concentration
- Surdose: confusion, angoisse, panique, délire, désorientation

Troubles cognitifs liés au THC

- Mémoire
- Motivation
- Concentration

Volkow et al: *Effects of cannabis Use on human behaviour, including cognition, motivation and psychosis, a review.* JAMA Psychiatry, March 2016, vol 73, N 3

«Pétard du matin, poil dans la main. Pétard du soir, trou de mémoire...»

Prof G. Ostermann, CHUV, 27 mai 2019

Cannabis et psychose

- Le cannabis ne rend pas schizophrène mais peut précipiter l'entrée dans la maladie pour des personnes prédisposées/vulnérable



Opioïdes

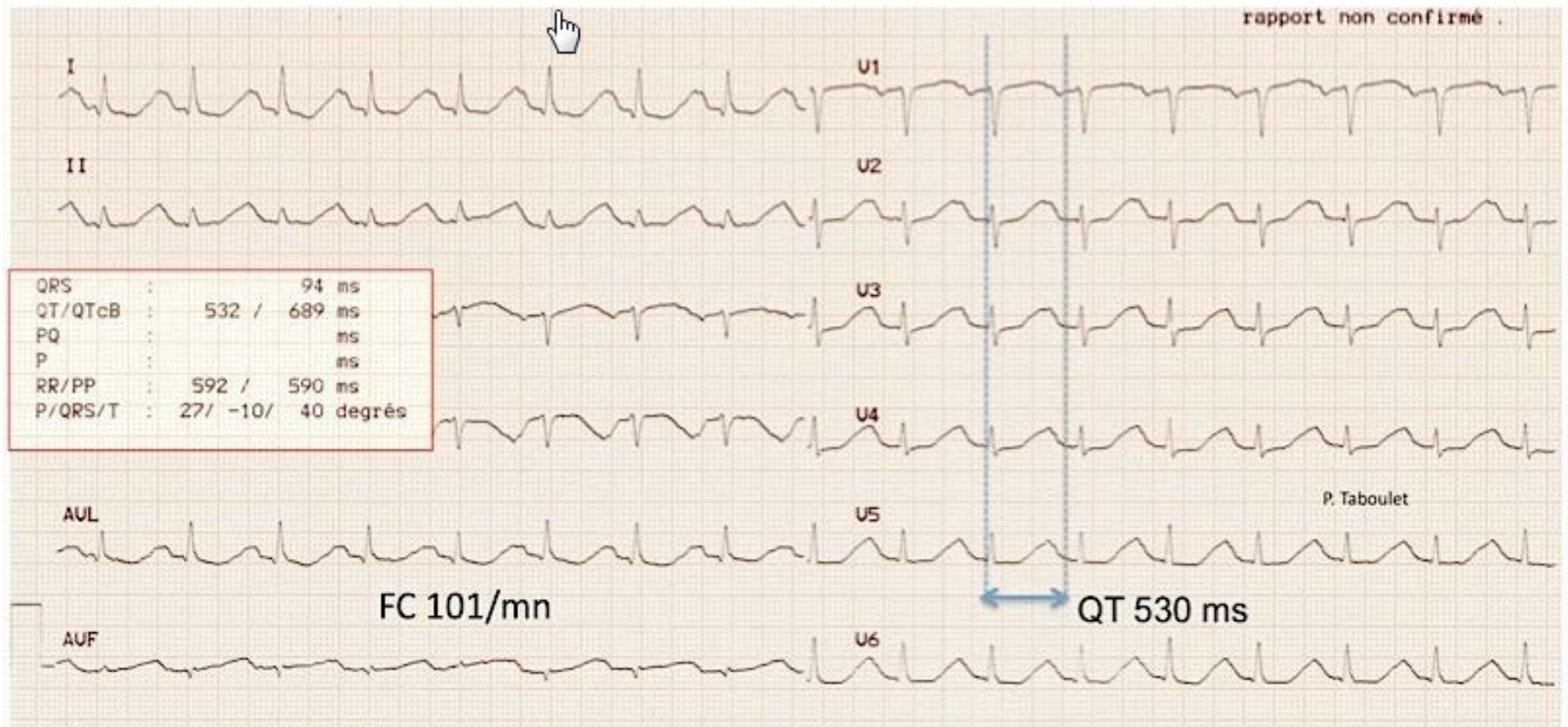
Traitement agoniste opioïde (TAO: Méthadone

- Opioïde de longue demi-vie d'élimination (24-36h), agoniste des récepteurs mu et kappa, comme la morphine et la diacétylmorphine (héroïne), de demi-vie plus courte (2-6h)
- Inhibe la sensation de manque
- Diminue le craving
- A dose élevée bloque les effets d'une prise additionnelle d'héroïne
- Diminution considérable de l'exposition aux risques liés au surdosage accidentelle, à l'hygiène d'injection et aux risques pénaux
- **!!! PAS DE TOXICITE CHRONIQUE !!!**

Le bilan initial

- Balance bénéfices/risques très en faveur d'un démarrage **sans délai d'un TAO, dès l'indication posée**
- Evaluation usage, prises de risques, tentatives passées de reprise de contrôle et réseau de soins préexistant
- Signes de sevrage ou d'intoxication
- Bandelette ou toxicologie urines
- ECG : QTc corrigé: < 450 ms?
- Sérologies HCV, HIV; vaccination hep A et B
- Téléphone au médecin cantonal en attendant de compléter formalités d'autorisation (varie selon cantons) pour prévenir le risque de double prescription

Risque de QTc allongé au-delà de 120 mg



Risque théorique de torsades de pointes,
Si QTc > 500 ms changement urgent de TAOs!

Alternatives à la méthadone

- **Buprénorphine** (Subutex®) agoniste partiel (effet plafond, meilleur profil sécuritaire que la méthadone en per os)
- **Morphine** à libération prolongée : principal intérêt, pas de métabolisme hépatique, pas de QT allongé, sevrage plus court (1/2 vie courte), donc protection de moindre durée en cas d'arrêt intempestif
- **L-méthadone**: intérêt énantiomère actif sans toxicité cardiaque mais 7 fois plus cher que la méthadone

- La prescription de méthadone à long terme (et ses alternatives) constitue le premier choix (tout particulièrement en cas de grossesse et d'incarcération)
- Dose de démarrage non létale : MTD 30 mg/j ou BPR 2 à 4 mg (jusqu'à 3x8 mg) ou morphine retard 200 mg/j
- Pour toute problématique complexe, centres spécialisés de proximité (cf. romandieaddiction.ch) et fiches des conduites à tenir sur praticiens-addictions.ch

Cas particulier de l'héroïne pharmaceutique (diacétylmorphine)

- Pour le sous groupe des « non-répondeurs » avec les TAOs classiques
- Uniquement dans des centres disposant d'un agrément OFSP et répondant à des normes strictes de remise sur place 2x / j (ou plus) 7 jrs / 7
- IV ou per os
- Prise de risque par rapport aux TAOs «classiques» compensée par le fait que la personne n'a plus de raison d'avoir des consommations parallèles

